



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ساميه ثابت عبد الحميد عبد النعيم

العنوان : الجيزة

الحي / المدينة : عين شمس

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

رقم البطاقة : 26903012501925 رقم التليفون : 01204024183

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-03-1969 المهنة : لاتعمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الأروماتيز [14161]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ساميه ثابت عبد الحميد عبد النعيم National ID: 26903012501925	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





reda,ia
mess



Name: ساميه ثابت عبدالحميد		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 2951			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
FEMARA CALCIUM 1*1*90 ONE ALPHA CT CAP 20/9/2025 RT BREAST AXILLARY LYMPHADENOPATHY SM 15/10/2025 FREE O/E NAD.			
56-year-old patient with left breast cancer, invasive ductal carcinoma grade 2, ER 7/8, PR 7/8, HER-2 negative, Ki-67 15%. Upfront left breast conserving surgery with sentinel lymph node dissection performed 9/2021 with ypT2N0M0, 0/5 nodes positive. Post-operative radiotherapy to the breast and axilla delivered on 20/9/2025. Current endocrine therapy with Femara (letrozole) 1 mg daily has been ongoing since 10/2021.			
Clinical pharmacy note: weight 70 kg, serum creatinine 1.2 mg/dL, creatinine clearance 57 mL/min. Zometa 3.5 mg administered.			
On 13/04/2026, a follow-up CT chest was performed, revealing tiny pulmonary nodules. Ultrasound of the left breast showed a fatty sparing area (HFL) that was noted for further evaluation.			
On 17/05/2026, the patient continued Femara for a total of three months, with pharmacy and PAUS monitoring for suspicious HFL.			
On 17/08/2026, abdominal ultrasound demonstrated a hepatic focal fatty sparing area. The patient reports bony aches primarily at the left shoulder, prompting consideration of a bone scan and contrast-enhanced CT of the chest and abdomen for further assessment.			
تحريراً في ,			
		التاريخ : 20-09-2026	الوقت :
		إيه مدحت بدوي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,			

تقرير الباثولوجي

1

National Women's Health Initiative
Pathology Lab

معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة

Pathology Report

Name: سامية ثابت عبدالمنعم عبدالمتعم

Age: 52 years.

Clinical data: left breast mass

Specimen type: tru cut biopsy

Date (Received): 30/6/2021.

Date (reported): 13/7/2021

Lab. Number: 1395/ 21

Hospital Number: صحة المرأة

Gross Examination:

- Procedure: tru cut biopsy
- Localization: Lt
- Immunohistochemistry technique: Sections prepared from paraffin block for immune staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2
ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 CLONE (4B5) & Anti-K-67 (30-9)

Microscopic examination:

- Histological type: IDC
- Grade II
- Examination of ER stained slide show intense nuclear stain in 90% of the tumor cells.
- Examination of PR stained slide show strong nuclear stain in 90% of the tumor cells.
- Examination of HER2 stained slide show no staining of tumor cells.
- Examination of Ki67 stained showed 15% nuclear reactivity.

Diagnosis:

Left breast mass, tru cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma GII.
- ER: Positive (7/8).
- PR: Positive (7/8).
- HER-2: negative (score 0).
- Ki67: 15%

Prof. Amal Hareedy
Dr. Rana Fath



Patient Name: Samia Thabet Abdel Hameed Abdel Na'eem	Date : 19/04/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 3308/2021	Pat. ID: 20827

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had left CBS in

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Basma Mohamed

د. باسم محمد جبرام على الندى

Patient Name: Samia Thabet Abdel Hameed Abdel Na'eem	Date : 20/09/2025
Exam : TRIPHASIC ABDOMEN & PELVIS	Age : 56 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 20827

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

****A known case of right breast cancer**

I Chest: -

- Right breast calcified mass measures 3.5 x 2.9 mm .
- Right axillary enlarged lymph nodes the largest measures 2.6 x 2.1 cm
- Few enlarged pulmonary nodules thw largest at right upper lobe 5mm.
- Mosaic perfudion of both lung lobes .
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous CT texture. Segment VIII calcification likely post granulomatous
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

III The scanned skeleton:

- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

Opinion:

**Right breast mass with axillary lymphadenopathy .
No pulmonary , hepatic or bony metastatic deposits.**

Dr. Reham Khedr, MD

Signature Reeham.Khader
24/09/2025 12:48 AM

THABIT, SMEA Patient ID: 116018096 DOB: 26-May-1975 Date: 10-Jun-2024

Patient Lastname: Thabit
Patient Firstname: SMEA
HIS Patient ID: 116018096
RIS Patient ID: 148062
Date of Birth: 26/05/1975

Procedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (10/6/2024)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP
Revealed:

- " No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- " Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- " Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- " Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- " No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated
Rawan Sherra
Omnia Talaat,MD

===== REPORT TEXT ENDE =====

مسح زرع
على العظام

Patient's Name: Samia Thabet Abdul Hamid Abdel Naim
Date: 2026-09-09
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- o Left breast calcifications are noted for sono-mammography.
- o Left upper lobe subpleural reticulations likely post radiation sequelae.
- o No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- o No consolidation or collapse.
- o No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- o No pleural or pericardial collection.
- o Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- o Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. Few bilobar well defined hypodense non enhancing focal lesions largest measuring 68 x 57 mm at segment VI. No dilated biliary radicles.
- o Cholecystectomy clips are noted.
- o Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- o Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- o A well defined hypodense lesion is seen inseparable from the lower uterine segment measuring 28 x 22 mm for MR assessment.
- o The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- o Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- o No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- o No ascites.
- o Left ischium tiny sclerotic focus likely bone island.

Opinion:

Patient's Name: Samia Thabet Abdul Hamid Abdel Naim
Date: 2026-09-09
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- ❖ Few bilobar hypodense hepatic focal lesions ? cysts for dynamic MR study.
- ❖ Lower uterine segment hypodense lesion for MR assessment.
- ❖ Left ischium sclerotic focus likely bone island.

Dr.sherif Wagdy